

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0220

Paginas del documento: 14

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

A incompatibilidade entre o sexo anatômico e a identidade de gênero faz com que os indivíduos trans frequentemente busquem o processo de afirmação de gênero⁴. Tal mecanismo consiste em uma série de procedimentos de modificação corpórea, mediante a realização de intervenções cirúrgicas e/ou a partir da terapia hormonal, com o intuito de reduzir aspectos sexuais secundários induzidos biologicamente, bem como introduzir características sexuais compatíveis com a identidade de gênero⁵.

Nessa perspectiva, foi estabelecido em 2008, o Processo Transexualizador (PrTr) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). O PrTr abrange uma série de procedimentos, serviços ambulatoriais e hospitalares voltados para a saúde de transexuais e travestis que expressem o desejo de modificar características corporais e sexuais⁶. Entretanto, o acesso aos serviços ofertados pelo PrTr apresenta diversas barreiras associadas ao déficit em quantitativo ou variabilidade dos recursos e procedimentos, acrescido com as limitações geográficas das unidades de saúde habilitadas para oferta do PrTr, tendo em vista que das dez instituições existentes no Brasil, seis situam-se na região sudeste⁷.

As restrições de acesso ao PrTr refletem em ações como o uso indiscriminado de estradiol, progesterona e testosterona, realização de intervenções cirúrgicas e procedimentos estéticos clandestinos, a exemplo da aplicação de silicone líquido industrial (SLI)⁸. A aplicação clandestina de injeções SLI é frequentemente utilizada por travestis e mulheres transexuais. O uso desta substância associa-se a diversos problemas de saúde, dentre os quais evidenciam-se as necroses teciduais, processos infecciosos, migração do produto para outras áreas do corpo, deformidades, embolia pulmonar e até mesmo o óbito⁹⁻¹⁰.

Perante o exposto, o presente estudo justifica-se pela lacuna no desenvolvimento de pesquisas voltadas para o processo de afirmação de gênero e dos seus reflexos na saúde transexual. Além disso, reforça-se que, por se tratar de uma população invisibilizada frequentemente afastada dos serviços de saúde, existem diversas dúvidas inerentes a abordagem terapêutica específica para esse grupo populacional. Nessa perspectiva, o estudo fornece importantes bases para os profissionais de saúde na elaboração de planos de cuidado baseados nos desafios e nas reais necessidades do público transexual. Dessa forma, o objetivo do estudo é analisar os impactos do processo de afirmação de gênero na saúde da população transexual.

MÉTODOS

Área do estudo

perspectiva, os critérios de inclusão da pesquisa compreendem a 8 anos e a participação regular nas atividades desenvolvidas na não Governamental (ONG). Enquanto os critérios de não inclusão referem-se a presença de comprometimento cognitivo grave.

A estratégia para a coleta de dados consistiu em estabelecer contato com a coordenação da Astra, com o intuito de explicitar os objetivos e relevância da pesquisa, além de obter uma troca de informações/experiências concernentes ao funcionamento da instituição, linhas de atuação e missão, de modo a adaptar a pesquisa, respeitando os princípios e valores institucionais. Assim, foi criado um termo de concordância institucional, assinado pela gestora da ONG, assegurando a consolidação da parceria entre a Astra e o grupo de pesquisas na realização da coleta de dados.

Coleta de dados

Processo de validação

No período de agosto a dezembro de 2022, os instrumentos de coleta de dados quantitativos passaram por um processo de validação por um comitê de três juízes especialistas em estudos sobre a população LGBTQIAPN+. Os pesquisadores foram convidados e selecionados via amostragem não probabilística por conveniência, mediante a análise do Currículo Lattes. Após a avaliação das orientações dos especialistas, houve a adaptação dos questionários, buscando consolidar as variáveis do estudo.

Caracterização dos instrumentos

Instrumentos Quantitativos

Foi aplicado, via *Google Forms*, no período de janeiro de 2023 a setembro de 2023 o instrumento semiestruturado de coleta de dados quantitativos “Avaliação sociodemográfica”. O questionário foi disponibilizado no formato de *link* para a gestora da Astra. O instrumento foi embasado nos estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística¹², da Rede Nacional de Pessoas Transexuais¹³ e de Barrientos-Delgado e colaboradores¹⁴. Tal instrumento é composto pelas variáveis: identidade de gênero, orientação sexual, descrição étnica, escolaridade máxima e rendimento mensal. Além disso, aplicou-se o instrumento “Saúde sexual e imagem corporal”, de caráter quantitativo, baseado nos estudos da Rede Nacional de Pessoas Transexuais¹² e de Carone e colaboradores¹⁵. O instrumento é composto pelas variáveis: hormonioterapia, intervenções cirúrgicas de modificação corporal e efeitos colaterais.

Análise de dados

A tabulação e organização do banco de dados foram realizadas no programa Excel e em seguida analisados estatisticamente pelo software *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) 25.0, a fim de obter as frequências absolutas e relativas, com o intervalo de confiança de 95% para apresentar significância estatística ($p < 0,05$). A

m nº de parecer 5.742.860, CAAE: 61245522.7.0000.5371. Durante das etapas metodológicas foram contemplados e resguardados os egais, de acordo com a Resolução nº 466/2012, segundo a qual os participantes receberam orientações e esclarecimentos acerca da participação voluntária, objetivo do estudo e etapas metodológicas. Os participantes que concordaram em participar assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

RESULTADOS

Participaram do estudo 58 transexuais, com faixa etária entre 18 e 61 anos, dentre os quais 23 (39,7%) eram homens transexuais, enquanto a orientação sexual mais observada foi heterossexual 22 (37,9%). O estudo evidenciou que, dentre os entrevistados, 30 (51,8%) possuem o ensino médio como grau de formação máxima e 24 (41,4%) são negros. Observou-se padrão de vulnerabilidade econômica expresso pela maioria dos indivíduos sem acesso a renda mensal e com até 1 salário-mínimo (Tabela 1).

Ao avaliar os processos de afirmação de gênero, verificou-se que 29 (50,0%) afirmam que realiza ou já realizou a hormonioterapia, dentre os quais a maior parcela teve o acompanhamento de um profissional de saúde qualificado. Outro levantamento realizado refere-se à modificação corporal por meio de cirurgias, neste cenário, a maioria (75,9%) dos entrevistados negam a utilização deste mecanismo. Do total de voluntários que realizaram intervenções cirúrgicas de modificação corporal, a maior parte (85,7%) alega ter realizado em unidades de saúde legalizadas (Tabela 2).

Conforme os dados apresentados na Tabela 2, a maioria dos entrevistados relataram terem apresentado efeitos colaterais durante a terapia hormonal. A Figura 1 apresenta a distribuição dos eventos adversos decorrentes da hormonioterapia. Nas mulheres trans destacam-se os efeitos conjuntos: náuseas/vômitos, tontura, dor de cabeça, elevação da pressão arterial sistêmica (PA) – cinco (37,5%). Enquanto nos homens trans destacam-se dor de cabeça, elevação da PA – sete (42,8%).

A Tabela 2 evidencia que a menor parcela dos transexuais foram submetidos a procedimentos cirúrgicos de modificação corporal. A maioria das mulheres transexuais 57,1% realizaram intervenções cirúrgicas nas mamas (colocação de próteses de silicone), enquanto 28,6% foram submetidas a intervenções cirúrgicas na face, glúteos e coxas e 14,3% na face. Já 100% dos homens transexuais realizaram procedimentos cirúrgicos nas mamas (mastectomia).

a 35 anos	8 (13,8)
a 41 anos	8 (13,8)
42 a 46 anos	4 (6,9)
47 a 51 anos	1 (1,7)
> 60 anos	1 (1,7)
Identidade de gênero	n (%)
Mulher trans	18 (31,0)
Homem trans	23 (39,7)
Não binário	17 (29,3)
Orientação sexual	n (%)
Heterossexual	22 (37,9)
Lésbica	6 (10,3)
Gay	6 (10,3)
Bissexual	8 (13,8)
Pansexual	14 (24,2)
Assexual	2 (3,5)
Etnia	n (%)
Negro	24 (41,4)
Branco	16 (27,6)
Pardo	16 (27,6)
Indígena	1 (1,7)
Não sabe responder	1 (1,7)
Escolaridade (máxima)	n (%)
Ensino fundamental	9 (15,5)
Ensino médio	30 (51,8)
Ensino superior	12 (20,7)
Ensino técnico profissional	6 (10,3)
Mestrado	1 (1,7)
Rendimento mensal (individual)*	n (%)
Não tem renda	25 (43,1)
Até 1 salário-mínimo	22 (37,9)
De 1 a 3 salários-mínimos	6 (10,3)
De 3 a 6 salários-mínimos	3 (5,2)
Prefiro não declarar	2 (3,5)

Legenda:*Valor do salário-mínimo: R\$ 1.320 (US\$ 238,13).

Fonte: Os autores (2023).

	Prefere não declarar	1 (1,7)
	hormonioterapia deu-se mediante as orientações de um profissional de saúde?	n (%)
	Sim	17 (58,6)
	Não	12 (41,4)
	Durante a hormonioterapia apresentou ou apresenta algum efeito colateral?	n (%)
	Sim	15 (51,7)
	Não	14 (48,3)
	Já passou por alguma cirurgia de modificação corporal?	n (%)
	Sim	14 (24,1)
	Não	44 (75,9)
	Caso tenha passado por algum processo cirúrgico de modificação corporal, este procedimento foi realizado em uma unidade de saúde legalizada?	n (%)
	Sim	12 (85,7)
	Não	2 (14,3)
	Caso tenha passado por intervenções hormonais ou cirurgias de modificação corporal, esses procedimentos foram realizados em qual sistema de saúde?	n (%)
	Sistema público	7 (12,1)
	Sistema privado	12 (20,7)
	Ambos os sistemas	5 (8,6)
	Não realiza	34 (58,6)

Fonte: Os autores (2023).

De acordo com a análise dos componentes principais (PCA), os dois primeiros componentes da PCA, a PC1 e a PC2, explicam a maior parte da variação dos dados (68,48%). Dessa forma, foi possível agrupar os transexuais em três subgrupos diferentes, de acordo com o grau de semelhança das interações dos membros de cada conjunto. A formação dos subgrupos apresentou a seguinte conformação: o subgrupo G1, é formado pelos eixos PC1+ e PC2+, totaliza 28 indivíduos; o subgrupo G2, é formado pelos eixos PC1- e PC2+, totaliza 13 indivíduos; e, o subgrupo G3 é formado pelos eixos PC1- e PC2-, totalizando 16 indivíduos.

O subgrupo G1 é composto por indivíduos que não realizaram hormonioterapia e que não se submeteram a intervenções cirúrgicas de modificação corporal, sendo heterogêneo e composto por mulheres trans, homens trans e não-binários. No tocante ao uso do nome social, 4 (100%) das mulheres transexuais e 12 (75%) dos não-binários afirmaram que a sociedade em geral respeita o seu nome social, enquanto 5 (62,5%)

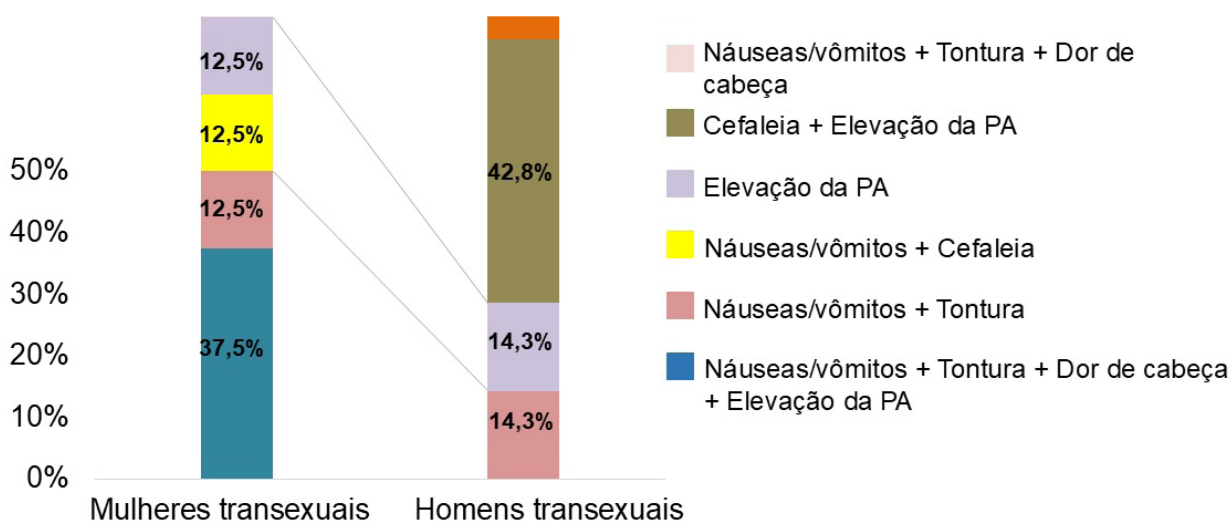


Figura 1. Distribuição dos efeitos colaterais da terapia hormonal em mulheres e homens transexuais. Aracaju, SE, Brasil, 2023

Fonte: Os autores (2023).

O subgrupo G2 é composto por homens e mulheres que realizaram hormonioterapia e cirurgias de modificação corporal. A maioria das mulheres trans relataram a realização da hormonioterapia sem o acompanhamento de um profissional de saúde, enquanto 6 (100%) dos homens trans afirmaram ter tido o acompanhamento de profissionais de saúde durante a terapia hormonal. No que se refere aos efeitos colaterais decorrentes da hormonioterapia, a maioria das mulheres trans relataram ocorrência, ao passo que a maioria dos homens trans negaram efeitos adversos. Em relação a realização de cirurgias de modificação corporal, 2 (28,57%) das mulheres transexuais relataram que realizaram esses procedimentos em unidades de saúde não legalizadas (Tabela 3).

O subgrupo G3 é composto por mulheres e homens trans que realizaram hormonioterapia e que não se submeteram a intervenções cirúrgicas de modificação corporal. A maioria das mulheres trans afirmou que realizou a hormonioterapia sem orientações de um profissional de saúde, enquanto quase todos os homens trans tiveram o acompanhamento profissional durante a terapia hormonal (Tabela 3).

No que concerne a realização do exame citopatológico, o público-alvo representou 36 mulheres cisgêneros e 33 homens trans e não-binários. Observou-se que a frequência de realização do exame diferiu entre os dois grupos, uma vez que 24 (66,66%) das mulheres cisgêneros realizam o exame anualmente, enquanto 16 (48,48%) dos homens trans e não-binários não o realizam (Figura 2). Foi possível verificar que os homens trans e não-binários apresentam 16 vezes mais chances de não realizar o exame citopatológico, comparados às mulheres cisgêneros (IC95% entre 3,29 a 77,76; $p=0,0002$).

	nome	100	0	37,5	62,5	75	25	
	terapia	0	100	0	100	0	100	
Modificação corporal		0	100	0	100	0	100	
Grupo 2 (13 indivíduos)								
Variáveis	Mulher trans (7)		Homem trans (6)		Não-binário (0)			
	Sim (%)	Não (%)	Sim (%)	Não (%)	Sim (%)	Não (%)		
Respeito ao uso do nome social	85,71	14,29	100	0	0	0		
Realizam hormonioterapia	100	0	100	0	0	0		
Orientação profissional de saúde	28,57	71,43	100	0	0	0		
Efeitos colaterais	71,43	28,57	33,33	66,67	0	0		
Modificação corporal	100	0	100	0	0	0		
Unidade legalizada	71,43	28,57	100	0	0	0		
Sistema utilizado	Públ.	Priv.	Públ.	Priv.	A.	NR	NR	
	85,71	14,29	66,67	16,66	16,66	0	0	
Grupo 3 (16 indivíduos)								
Variáveis	Mulher trans (6)		Homem trans (10)		Não-binário (0)			
	Sim (%)	Não (%)	Sim (%)	Não (%)	Sim (%)	Não (%)		
Respeito ao uso do nome social	83,33	16,67	80	20	0	0		
Realizam hormonioterapia	100	0	100	0	0	0		
Orientação profissional de saúde	16,67	83,33	90	10	0	0		
Efeitos colaterais	50	50	50	50	0	0		
Modificação corporal	0	100	0	100	0	0		
Sistema utilizado	Públ. (%)	NI (%)	Públ. (%)	Priv. (%)	A. (%)	NI (%)	NR	NR
	33,33	66,67	20	30	20	30	0	0

Legenda: **Públ**- Sistema Público de Saúde; **Priv**- Sistema Privado de Saúde; **A**- Ambos os sistemas de Saúde; **NI**- Sistema não informado; **NR**- Não realizou.
 Fonte: Os autores (2023).

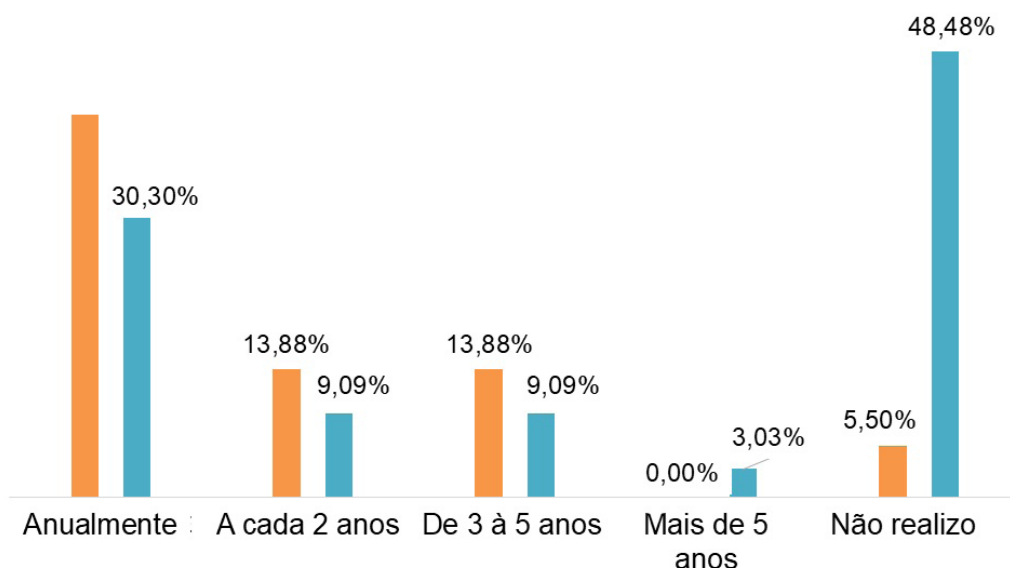


Figura 2. Comparativo entre a frequência de realização do exame citopatológico em mulheres cisgêneras X homens trans e não-binários, Aracaju, SE, Brasil, 2023

Fonte: Os autores (2023).

DISCUSSÃO

O presente estudo evidencia fragilidades no nível de escolaridade da população transexual e o seu reflexo no baixo rendimento econômico desses indivíduos. Conforme o dossiê publicado em 2022 pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), apenas 0,02% dos transexuais estão inseridos nas universidades¹⁶.

Por conseguinte, observa-se disparidades sociais, sobretudo na escassez de oportunidades no acesso à educação inclusiva e na ocupação de cargos bem remunerados. Destaca-se ainda que as limitações de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento de ações que incentivem a abertura de vagas formais de emprego para o público transgênero, contribuem para que grande parcela dos transexuais encontrem-se desempregados ou em subempregos como a prostituição, sendo expostos a um cenário de vulnerabilidade socioeconômica¹⁷⁻¹⁸.

O processo de afirmação de gênero tem o potencial de promover impactos positivos à saúde do público transexual, uma vez que reduz os efeitos da incongruência entre a identidade de gênero e as características biológicas por meio de procedimentos como intervenções cirúrgicas, reconhecimento legal do gênero e hormonioterapia¹⁹. Nesse sentido, o presente estudo demonstra como tais mecanismos repercutem de diferentes maneiras na saúde de homens e mulheres transexuais.

Este estudo apresenta uma tendência associada às mulheres transexuais realizarem o processo de hormonioterapia sem o acompanhamento profissional. Esse dado pode

tações profissionais durante a realização da hormonioterapia. Tal importância dos profissionais de saúde na prevenção de complicações de tratamentos seguros e legalizados²¹.

Um estudo realizado na Bahia evidencia que há uma facilidade na obtenção do estradiol e da progesterona sem receita médica nos ambientes farmacêuticos brasileiros, sendo esta uma condição favorável para a prática da automedicação, a qual representa um fator de risco para a ocorrência de eventos adversos⁸. Ademais, as barreiras no acesso aos serviços de saúde podem estimular a automedicação, bem como as condições socioeconômicas podem inferir na dedução de que quanto maior o nível de hormônio administrado, as mudanças corpóreas desejadas ocorrerão mais rapidamente²².

A hormonioterapia pode desencadear alterações metabólicas, cardiovasculares e endócrinas que variam entre homens e mulheres transexuais, devido às diferenças nas substâncias utilizadas e seus distintos mecanismos fisiológicos²³. Ao avaliar a distribuição dos efeitos colaterais do estudo, verificou-se que a elevação da pressão arterial foi um ponto em comum entre as duas identidades de gênero. Entretanto, os mecanismos que envolvem essa condição são diferentes, em homens transexuais, a hipertensão é vinculada ao aumento da viscosidade sanguínea associada ao uso da testosterona²⁴, já em mulheres transexuais está relacionado às repercussões do estrogênio no risco de eventos tromboembólicos²⁵.

O estudo destacou que a maioria dos transexuais não se submeteram a intervenções cirúrgicas de modificação corporal, esse fato pode associar-se à dificuldade de acesso ao Processo Transsexualizador (PrTr). Apesar das unidades de saúde especializadas ofertarem uma diversidade de procedimentos cirúrgicos, tais como histerectomia, tireoplastia, implantes de próteses mamárias e mastectomia, o tempo de espera para a aquisição das cirurgias ainda é considerado alto, fazendo com que muitos indivíduos não tenham acesso às intervenções desejadas. Somado a isso, existem restrições geográficas, especialmente na região nordeste, que conta apenas com um hospital habilitado com os serviços do PrTr, situado na região metropolitana de Recife²⁶.

A dificuldade em acessar os procedimentos de modificação corporal pode aumentar os riscos de utilização de serviços sem regulamentação estrutural e profissional adequadas, predispondo graves consequências para a saúde, como a rejeição de implantes, ocorrências de infecções e hemorragias, complicações anestésicas e até mesmo o óbito²⁷⁻²⁸.

No que se refere ao rastreamento de câncer de colo uterino em não-binários e homens trans não histerectomizados, o presente estudo destacou a baixa adesão desse público na realização periódica do exame citopatológico. Tais achados corroboram com o estudo realizado nos Estados Unidos, o qual ressaltou que cerca de 51% dos participantes transexuais não realizaram o exame citopatológico nos últimos 3 anos. O estudo destacou ainda que a maioria dos transexuais preferem realizar a auto-amostragem do HPV como rastreio primário do câncer do colo do útero, com o intuito



O presente estudo viabilizou a análise dos impactos do processo de afirmação de gênero na saúde da população transexual do nordeste brasileiro, demonstrando que a hormonioterapia é um mecanismo frequentemente aplicado para a obtenção de características físicas compatíveis com a identidade de gênero. As mulheres transexuais apresentam-se mais propensas a realizarem a hormonioterapia sem o acompanhamento de um profissional de saúde, sendo esse fato associado ao aumento da ocorrência de efeitos colaterais. Verificou-se que a maioria dos transexuais não se submeteram a cirurgias afirmativas, esse dado pode associar-se à dificuldade de acesso aos serviços de saúde.

A pesquisa possui implicações significativas para as áreas da saúde e da Enfermagem, pois fornece um levantamento sociodemográfico e clínico sobre os impactos do processo de afirmação de gênero na saúde transexual. A compreensão desses parâmetros contribui para a capacitação no acompanhamento de indivíduos em terapia hormonal e cirurgias afirmativas, buscando a redução de riscos e promoção de melhores desfechos clínicos, além de incentivar o desenvolvimento de um sistema de saúde mais equitativo e inclusivo.

AGRADECIMENTOS



Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) - código de financiamento 001 (Projeto número: 88887.940250/2024-00) e a Organização Não Governamental Astra- Direitos e Cidadania LGBT.

REFERÊNCIAS



ache and elevated blood pressure. About 41.0% performed hormone therapy without the healthcare professional. Transsexuals and non-binaries were 16 times ($p=0.0002$) more likely to undergo a gynecological examination. These data reinforce the vulnerability scenario of the population in the health context. **n:** The study demonstrated that institutional barriers drive the transgender population away from health services, generating limitations in access to preventive care with an emphasis on hormone therapy.

KEYWORDS: Transsexualism; Transgender Persons; Health Services for Transgender Persons; Access to Health Services; Health Vulnerability.

El proceso de afirmación de género y los impactos en la salud de las personas transgénero*

RESUMEN

Objetivo: Analizar los impactos del proceso de afirmación de género en la salud de la población transexual. **Método:** Estudio transversal y cuantitativo, realizado con personas transgénero de Aracaju, Sergipe, Brasil, entre enero y septiembre de 2023, utilizando instrumentos sociodemográficos y de salud. El análisis se realizó mediante el componente principal y estadísticas descriptivas. **Resultados:** De las 58 participantes, el 51,7 % presentó efectos secundarios durante la hormonoterapia, entre los que destacaron cefalea y aumento de la presión arterial. Alrededor del 41,0 % se sometió a la terapia hormonal sin el seguimiento de un profesional sanitario cualificado. Las personas transgénero y no binarias presentaron 16 veces ($p=0,0002$) más probabilidades de no realizarse la citología. Estos datos refuerzan el panorama de vulnerabilidad de la población en el contexto de la salud. **Conclusión:** El estudio demostró que las barreras institucionales alejan a la población transexual de los servicios de salud, lo que genera limitaciones en el acceso a la atención preventiva, con énfasis en la terapia hormonal.

DESCRIPTORES: Transexualidad; Personas Transgénero; Servicios de Salud para las Personas Transgénero; Acceso a la Atención de Salud; Vulnerabilidad en Salud.

***Artigo extraído da dissertação do mestrado:** "Fatores condicionantes de saúde e a configuração das interações sociais da população LGBTQIA+ inserida no Estado de Sergipe", Universidade Tiradentes, Aracaju, SE, Brasil, 2024.

Recebido em: 23/07/2024

Aprovado em: 08/06/2025

Editor associado: Dra. Cremilde Aparecida Trindade Radovanovic

Contribuição dos autores:

Contribuições substanciais para a concepção ou desenho do estudo; ou a aquisição, análise ou interpretação de dados do estudo - **Santana JT, Cardoso IG, de Oliveira VTP, Madi RR, Martins MCV, de Melo CM.** Elaboração e revisão crítica do conteúdo intelectual do estudo - **Santana JT, Madi RR, de Melo CM.** Responsável por todos os aspectos do estudo, assegurando as questões de precisão ou integridade de qualquer parte do estudo - **Santana JT, de Melo CM.** Todos os autores aprovaram a versão final do texto.

Conflitos de interesses:

Os autores declaram não haver conflitos de interesse a serem divulgados.

